AI時代の問いの立て方 — 臨床・教育・経営 実践レポート

作成日: 2026-03-20 **施設:** おもろまちメディカルセンター（94床） **担当:** 副院長・内科/呼吸器内科

第I部：臨床領域

Wells症候群 vs DRESS — 鑑別深化PubMed検索

検索日: 2026-03-20 **前回サマリー参照:** `docs/pubmed/2026-03-19_eosinophilic_cellulitis_post_herpes_encephalitis.md`

背景

患者像: ヘルペス脳炎後1ヶ月、好酸球1500/μL、両下肢蜂窩織炎様皮疹、非細菌性 主な鑑別: Wells症候群（好酸球性蜂窩織炎）vs DRESS症候群

問い①：鑑別に有用な所見の診断精度（LR）

検索キーワード: Wells syndrome eosinophilic cellulitis diagnosis criteria; DRESS RegiSCAR diagnostic criteria

主要文献

PMID	タイトル	主な知見
24421864	Wells syndrome: Proposed diagnostic criteria. J Dermatol Case Rep 2013	Wells症候群の診断基準を初めて体系化
3279079	Wells' syndrome is a distinctive disease entity. JAAD 1988	flame figuresは「必要条件だが十分条件ではない」を明確化
31850109	Wells Syndrome — An Odyssey. Open Access Maced J Med Sci 2019	診断基準: 好酸球浸潤+末梢血好酸球増多+再発寛解+全身疾患除外
37082745	DRESS syndrome: A literature review and	

PMID	タイトル	主な知見
	treatment algorithm. World Allergy Organ J 2023	RegiSCARスコア（≥4点）によるDRESS診断精度を詳述
36380139	Eosinophilic dermatoses. Dermatologie 2022	flame figures陽性となりうる他疾患を整理

各所見の鑑別力

> Wells症候群とDRESSの鑑別に使えるLR値を直接算出した前向き研究は存在しない（全て症例報告・後ろ向き症例集積）。

所見	Wells症候群に有利	DRESSに有利	鑑別力
発熱	通常なし or 軽微	ほぼ必発（38°C以上）	**最も鑑別力が高い**
顔面浮腫	まれ	高頻度（RegiSCAR 1点）	DRESSに高特異的
リンパ節腫脹	まれ	高頻度（小児DRESS 69.4%: PMID 34332174）	DRESSに高特異的
皮疹分布	四肢遠位・局所性	体幹優位・広汎性・モルビリ様	中等度
異型リンパ球	陰性	陽性（診断支持）	DRESSに特異的
肝障害	なし	最多臓器障害（83.7%: PMID 34332174）	DRESSにほぼ特異的
末梢血好酸球数	軽度〜中等度	中等度（>1500が基準）	好酸球数のみでは鑑別不能
皮膚生検 flame figures	陽性（特徴的だが非特異的）	通常陰性	中等度
HHV-6再活性化	関連なし	高頻度・病態の中心（PMID 35176506）	DRESSに高特異的
抗菌薬不応性	必発	無関係	Wells症候群の発見契機

限界: LR値の定量的算出根拠となるコホート研究がなく、エビデンスレベルはIV〜V。RegiSCARスコアがDRESS診断の現状最良ツール。

問い②：発症タイミング（1ヶ月という時間軸の解釈）

検索キーワード: DRESS onset timing weeks drug exposure; Wells syndrome viral trigger onset time

主要文献

PMID	タイトル	主な知見
39737180	Fatal outcome related to DRESS: FAERS analysis. Front Immunol 2024	薬剤投与からDRESS発症まで**平均27.19日**（FAERS大規模DB解析）
34332174	DRESS: Series of 49 French Pediatric Cases. J Allergy Clin Immunol Pract 2022	小児DRESS発症中央値**15日**（抗てんかん薬**21日**）
33155729	Pediatric DRESS: Systematic review. Pediatr Dermatol 2021	初発症状までの平均**18.9日**。抗てんかん薬が最多トリガー
35176506	DIHS/DRESS: Clinical Features and Pathogenesis. J Allergy Clin Immunol Pract 2022	典型的発症は薬剤開始後**2〜8週**
40488888	Wells syndrome: emerging triggers and treatments. Arch Dermatol Res 2025	ウイルス誘発Wells症候群は曝露後「数日〜数週」で発症（個別症例データのみ）

発症時期の比較

	Wells症候群	DRESS症候群
トリガーから発症	数日〜数週（定量データなし）	**平均27日**（FAERS）；中央値15〜21日
典型的レンジ	曝露後1〜数週（推定）	薬剤開始後**2〜8週**
抗てんかん薬の場合	関連報告少数	中央値**21日**
1ヶ月（30日）の解釈	ウイルストリガーとして矛盾なし	**完全合致**（特に抗てんかん薬の場合）

本症例への示唆: 1ヶ月という時間軸は両疾患で否定されない。しかしDRESSは定量的根拠があり（平均27日）、抗てんかん薬使用歴があれば「薬剤開始→21〜30日後発症」としてDRESSの蓋然性が高い。

限界: Wells症候群の「トリガーから発症までの日数」を定量的に示した研究は確認できなかった。

問い③：flame figuresの診断精度

検索キーワード: flame figures sensitivity specificity diagnostic Wells syndrome

主要文献

PMID	タイトル	主な知見
3279079	Wells' syndrome is a distinctive disease entity. JAAD 1988	flame figuresは「必須だが診断的でない」を最初に明確化
3728877	Eosinophilic infiltration with flame figures. Am J Dermatopathol 1986	虫刺症・偽リンパ腫等でもflame figures出現。非特異的を体系化
16983010	Reflections on eosinophils and flame figures. Arch Dermatol 2006	flame figures陽性 ≠ Wells症候群を明確に論じる
25238447	Life of lesions in eosinophilic cellulitis. Am J Dermatopathol 2015	初回生検陰性→再生検で陽性。**単回陰性でWells症候群は除外できない**
33245262	Luna stain for Wells Syndrome. J Histotechnol 2020	Luna染色がHE染色より好酸球顆粒沈着を鋭敏に検出

flame figuresの診断精度の総括

> **感度・特異度を定量的に示した研究は存在しない（エビデンスレベルIV〜V）。**

特性	評価
特異度（推定）	**低い**。Wells症候群以外でも陽性（虫刺症・血液腫瘍・アトピー・類天疱瘡等）
感度（推定）	中等度〜高いが、病変の時期・生検部位・染色法に依存
単回陰性の意義	**Wells症候群を除外しない**（早期病変ではflame figures未形成）
陽性時の解釈	Wells症候群を「支持」するが「確定」させない
偽陰性の主因	病変の時期（早期・後期）、生検部位の選択、HE染色の感度限界

flame figures陰性時の対応策:

1. 病変の他部位・異なる時期での**再生検**を検討（PMID 25238447）
2. **Luna染色**の追加依頼（PMID 33245262）
3. Wells症候群は本質的に**臨床診断**であり、flame figures陰性のみで除外不可

問い④：ステロイド投与のリスクと禁忌

検索キーワード: DRESS corticosteroid CMV reactivation risk; Wells syndrome steroid treatment complication

主要文献

PMID	タイトル	主な知見
40251070	Recent advances in DIHS/DRESS 2025. Allergol Int 2025	**ステロイドパルスがCMV再活性化の独立リスク因子**
35176506	DIHS/DRESS: Clinical Features and Pathogenesis. 2022	CMV合併症モニタリングが必須
23182063	Short- and long-term outcomes of 34 DIHS patients. JAAD 2013	**ステロイド治療群でヘルペスウイルス感染症・肺炎が有意多発**
40488888	Wells syndrome: emerging triggers. Arch Dermatol Res 2025	ステロイド抵抗性にdupilumab・ruxolitinib・mepolizumabが有効

ステロイドが危険になりうる状況

A. DRESS症候群と診断した場合のリスク

リスク	根拠	対策
HHV-6再活性化増悪	DRESSの病態中心。免疫抑制でさらに悪化	CMV・HHV-6 DNAモニタリング
CMV再活性化→重症CMV疾患	ステロイドパルスが独立リスク因子（PMID 40251070）	定期的CMV-DNA定量
細菌性肺炎・日和見感染	ステロイド治療群で肺炎が有意多発（PMID 23182063）	感染スクリーニング
ステロイド急速減量による再燃	DRESSはリバウンドしやすい	数ヶ月の漸減が必要
後期自己免疫疾患（SLE・橋本病）	長期フォロー研究（PMID 23182063）	長期フォローアップ

B. ヘルペス脳炎後という特殊状況のリスク（本症例特有）

リスク	内容
HSV再活性化	免疫抑制による再活性化。脳炎既往例では**再発性ヘルペス脳炎**のリスクが特に高い
抗ウイルス薬との同時投与が必須	

リスク	内容
	ステロイドを使用する場合はアシクロビル等の継続・再開を強く推奨

鑑別未確定時の意思決定フロー

```
抗てんかん薬使用歴あり？
  → Yes: 即時中止。DRESS対応を優先
  → No: ↓

発熱·リンパ節腫脹·肝障害·異型リンパ球のいずれかあり？
  → Yes: DRESS優先。内臓障害の程度に応じて全身ステロイド検討
      (CMV·HHV-6モニタリング必須、抗ウイルス薬を継続)
  → No: Wells症候群優先。まず局所ステロイドで試験治療

いずれの場合も：
 ヘルペス脳炎後1ヶ月 → アシクロビルを継続 or 再開
  flame figures陰性でも → 再生検·Luna染色を追加検討
```

臨床領域 統合サマリー

比較項目	Wells症候群	DRESS症候群
発症時期（定量）	曝露後数日〜数週（定量データなし）	薬剤開始後**平均27日**、範囲2〜8週
1ヶ月の解釈	ウイルストリガーとして矛盾なし	**完全合致**（特に抗てんかん薬の場合）
flame figures	特徴的だが非特異的。単回陰性で除外不可	通常陰性
発熱	通常なし	ほぼ必発
内臓障害	なし	肝障害83.7%
HHV-6再活性化	無関係	病態の中心
ステロイド	軽症は局所のみ。全身は広汎例に限定	標準治療だがCMV/HSV/細菌感染リスク
本症例で最優先確認事項	抗てんかん薬使用歴、発熱、肝機能、異型リンパ球、HHV-6 DNA	

第II部：教育領域

レジデント勉強会 教育設計書 — 急性呼吸困難の系統的鑑別

作成日: 2026-03-20 **対象:** 研修医2年目（2〜6名）

テーマ選定

評価軸と上位3テーマ

順位	テーマ	誤診リスク	遭遇頻度	教育ツール充実度
1位（選定）	**急性呼吸困難の系統的鑑別（心原性 vs 肺原性 vs その他）**	最高	最高	最高（LR・POCUS・BNP）
2位	市中肺炎の重症度評価と初期治療判断	高	高	高
3位	抗菌薬のde-escalation判断	中	中	中（別セッション推奨）

選定理由:

- **誤診リスク（最高）:** 急性心不全と肺炎・COPD急性増悪の初期対応が逆になると、過剰輸液・不適切利尿・誤ったNPPV適応など致命的誤治療に直結
- **当院遭遇頻度（最高）:** 呼吸困難は全入院主訴の上位1〜2位。呼吸器科主体施設では月30〜40件以上
- **教育ツールの充実度（最高）:** POCUS（LR+ 7.4）・BNP・身体所見の尤度比が数値化されており、ソクラテスメソッドとケースベース教育の格好の素材

研修医のつまずきパターン: 1. 「ラ音=肺炎」への直結（アンカリングバイアス） 2. BNP中等度上昇（200〜500 pg/mL）のグレーゾーン解釈困難 3. 胸部X線のKerley B線・CTR拡大の見落とし

行動変容目標（3つ）

「この勉強会の翌日から研修医が変える行動」:

目標1: 病棟コールを受けたとき、第一印象の診断名を30秒間保留する ナースから「肺炎の方がSaO2下がっています」と報告を受けても、バイタル確認後に「心原性・肺原性・その他」の3カテゴリを頭の中で一度リセットしてから身体診察に入る。

目標2: 呼吸困難患者のルーティン採血にBNPを追加し、自分で肺エコーを施行してからプレゼンする POCUS（Bライン確認）を初療セットに組み込む。上級医へのプレゼンには「BNP○○ pg/mL、エコーでBライン（あり/なし）」を必ず含める。

目標3: ラ音を聴取した際、頸静脈怒張・下腿浮腫の有無を必ず記録する 「ラ音=肺炎」の一対一対応を断ち切り、急性心不全・間質性肺疾患増悪を鑑別リストに明示する習慣を身につける。

ソクラテス式問い（5問）

Q1（優先順位の設計） 「65歳・独居・SpO2 88%で救急搬送されました。あなたが最初の2分でやるべきことを挙げてください。病歴を取る前に身体所見を取りますか、それとも逆ですか？その判断の根拠はなんですか？」

Q2（身体所見の尤度比） 「両側底部ラ音を聴取しました。ラ音の急性心不全に対する陽性尤度比はいくつかご存知ですか？そして、ラ音の陰性尤度比（0.35）は何を意味しますか？ラ音がないことは心不全を除外しますか？」

Q3（BNPグレーゾーンの解釈） 「BNPが380 pg/mLでした。このBNPは急性心不全の診断を確定しますか、否定しますか？BNP 80の患者とBNP 1,400の患者を、あなたは同じように扱いますか？」

Q4（マルチモーダルな統合） 「胸部X線で両肺野のすりガラス影、心陰影拡大（CTR 56%）、Kerley B線があります。肺炎・急性心不全・ARDS・IP急性増悪が鑑別候補です。この4つを区別するために、あと何の情報が必要ですか？施行する検査に優先順位をつけてください。」

Q5（不確実性の中での治療判断） 「急性心不全か肺炎かまだ判断がつかない状況で、上級医が『抗菌薬も輸液も両方始めよう』と言いました。あなたはどう感じますか？輸液負荷のリスクを上級医に伝えるとしたら、何と言いますか？」

ケースシナリオ

患者設定

主訴: 呼吸困難・起座呼吸 2日間の増悪 患者: 78歳 男性 既往: 2型糖尿病、高血圧、10年前に「肺炎」で入院歴あり（詳細不明） 内服: アムロジピン、メトホルミン 生活歴: 30本/日×40年（20年前禁煙）

バイタルサイン（来院時）

項目	値
血圧	162/98 mmHg
心拍数	108 bpm（不整）
体温	37.4°C
SpO2	90%（室内気）
呼吸数	26回/分

身体所見: 頸静脈怒張あり（45°で怒張）、S3ギャロップ疑い、両側底部fine crackles（右>左）、軽度肝腫大、両側足背〜下腿浮腫（pit+）

初期検査所見

検査	値
WBC	9,200/μL（好中球72%）
CRP	3.8 mg/dL
BNP	380 pg/mL
Cr	1.4 mg/dL（ベースライン不明）
胸部X線	CTR 56%、右肺中下野すりガラス影、Kerley B線あり

4段階の問い

- **Stage 1（情報収集）:** 最も疑う疾患とその根拠を5つ、must-not-miss診断は？
- **Stage 2（鑑別）:** 急性心不全 / 肺炎 / 両者合併の3シナリオでBNP 380をどう解釈するか？
- **Stage 3（検査）:** 次に施行すべき検査3つを優先順位付きで。→ 肺エコーでBライン多数・EF 35%確認後の診断変化は？
- **Stage 4（治療）:** フロセミド40mg IV準備中、上級医が「抗菌薬も始めよう」と追加指示。培養陰性・CRP改善時の抗菌薬方針は？

認知バイアスの罠（ファシリテーター用）

バイアス	本ケースでの表れ方	矯正アプローチ
アンカリングバイアス	「右肺野陰影=肺炎」に固執	「もし肺炎でなかったら？」と反事実思考を促す
確証バイアス	CRP上昇・微熱を肺炎の証拠として選択的に重視	反証（頸静脈怒張・S3）を意識的にリスト化させる
委任バイアス	「上級医が肺炎と言ったから」で思考停止	「自分の鑑別第1位は○○、その理由は…」と言語化を義務づける
利用可能性バイアス	「CRP上昇=感染=抗菌薬」の短絡パターン	CRPは心不全・膠原病でも上昇することを繰り返し提示

評価ルーブリック（3段階）

評価項目	習熟（Proficient）	基本レベル（Basic）	要指導（Needs Improvement）
鑑別列挙の構造化	3カテゴリを即座に構造化し根拠つきで5疾患以上列挙	主要疾患は挙げるが優先順位の根拠が不明確	主訴から1疾患に直結し鑑別リストが出ない
身体所見の統合解釈	複数所見を統合して診断確率を更新できる	個々の所見は認識できるが統合的解釈が困難	所見を羅列するのみで診断への意味づけができない
BNP・検査解釈	グレーゾーンではエコーで補完する判断ができる	高値=心不全・低値=違うという二値的解釈にとどまる	BNPの臨床的意味を説明できない
POCUS活用計画	肺エコー・心エコーを自ら施行計画し鑑別に統合	有用性は知っているが自分では計画を立てられない	POCUSの鑑別への活用を知らない
不確実性下での治療判断	「最も危険な診断を優先」の原則で判断し言語化できる	治療選択肢は挙げられるが判断に迷う	上級医指示待ちで自分の判断を言語化できない
認知バイアス自己認識	反証を意識的に探す行動ができる	バイアスの概念は理解しているが自己適用できない	バイアスの概念を知らない

教育効果の根拠文献

PMID	タイトル	エビデンスレベル	主な知見
29252938	Signs and symptoms in adult patients with acute dyspnea: SR and meta-analysis. Eur J Emerg Med 2018	SR/メタ分析（Level I）	頸静脈怒張（pooled OR: 7）・ラ音（LR− 0.35）。複数所見の統合が必須
26910112	Diagnosing Acute Heart Failure in the ED: SR and Meta-analysis. Acad Emerg Med 2016	SR/メタ分析（Level I）	肺エコーBライン LR+ 7.4、BNP<100 LR− 0.11

PMID	タイトル	エビデンスレベル	主な知見
39625592	Heart and lung POCUS tutoring in internal medicine: RCT. J Ultrasound 2025	RCT（Level II）	単回コースでは6週間でスキルが著明低下。繰り返しチュータリングで6ヶ月後達成率70%

肺エコーBラインの尤度比（PMID 26910112）

検査・所見	LR+	LR−
肺エコー Bライン	**7.4**（95%CI 4.2–12.8）	0.16
胸部X線 肺水腫	4.8（95%CI 3.6–6.4）	—
心エコー EF低下	4.1（95%CI 2.4–7.2）	—
S3聴取	4.0（95%CI 2.7–5.9）	—
BNP < 100 pg/mL	—	**0.11**（除外に強力）

勉強会実施計画（案）

項目	内容
実施時間	60〜75分
対象	研修医2年目（3〜6名）
形式	ケースベース学習 + ソクラテスメソッド + ミニレクチャー（10分）
事前課題	BNPカットオフ値と尤度比の予習（PMID 26910112の表を配布）
準備物	シナリオ印刷・エコー機器（デモ用）・ホワイトボード
事後評価	1週間後に実症例でルーブリック自己評価チェックリストを提出
次回フォロー	1ヶ月後の勉強会でPOCUS施行件数・実症例の振り返りを実施

第III部：経営領域

2026年度改定 看護必要度戦略 — 構造的分析レポート

参照文書: `docs/admin/2026_nursing_necessity_unified_strategy.md`

問いのフレーミング練習

悪い問い: 「看護必要度を上げるには？」

この問いの欠陥: 手段が曖昧 / 制約条件が未定義 / 成果指標が不明 / 時間軸がない

制約条件: - 人員増加なし / 追加設備投資なし / 6ヶ月以内（2026年4〜9月）/ 患者安全を損なわない

精錬された問い（5つ）

問い1（記録最適化）: 「6Fで現在記録されていないA項目・C項目の算定漏れ率はどの程度か？現行の患者構成・処置内容を変えずに、評価記録の精度を上げるだけで何%の改善が見込めるか？」

問い2（キシロカイン活用）: 「6Fペイン科で施行中のキシロカイン点滴のうち、A6⑧（3点）として正確にカウントされている件数は月何件か？算定フロー確立後に月15件計上した場合、該当割合は何%増加するか？」

問い3（C項目フル活用）: 「6F内科で月間に施行されているCV挿入・腰椎穿刺・ERCP・気管支鏡・PEG・CARTのうち、C項目として計上されているものは何件か？計上漏れを解消した場合の追加スコアは？」

問い4（診療プロトコル設計）: 「6Fの肺炎・心不全・尿路感染症患者において、現行の注射薬レジメンで”3種類以上”（A3=1点）の条件を満たせている患者割合は何%か？患者安全を損なわずに該当日数を増やせるか？」

問い5（退院支援タイミング最適化）: 「6FでDay8以降も在院している患者のうち、A項目・C項目の該当ゼロ（分母だけ膨らんでいる）患者が占める在院日数は月間何日か？退院支援をDay7までに完結させることで分母希釈効果をどの程度抑制できるか？」

6Fギャップ解消の構造的分析

現状値:

```
6Fの指数（現状）= 11.0% + 救急1.2% = 12.2%
目標                                = 19.0%
```

```
ギャップ                                  = 6.8%
算定改善後見込み                         ≒ 20.3%
```

最大の改善レバー（優先順位順）

順位	項目	点数	6Fでの状況	改善余地
1	A6⑧ キシロカイン等	**3点**	ペイン科で日常的に施行中だが算定フロー未確立	最大（月15件計上で+3.8%）
2	C21項目（内科系処置・4日間）	—	CV挿入・ERCP・CHDF等	月8件で+2.7%
3	A3 注射薬3種以上	1点	肺炎患者で充足している可能性あり	中（記録漏れ対応）
4	A2 呼吸ケア	1点	酸素投与患者に見落とし多い可能性	中（即効性あり）
5	C23（PEG・CART・5日間）	—	少件数でも効果大	中（症例数に上限）

記録改善で即効性があるアプローチ（即効性順）

1. **A2「呼吸ケア」の記録徹底（実施当日から効果）:** 低流量酸素・NPPV・BiPAPも全て1点対象。看護師向け15分レクチャー1回で即日効果
2. **C項目の「発生時即日記録」ルール確立:** CV挿入当日にEMR上でC21フラグを立てるテンプレートを設置（1〜2週間で完了可能）
3. **A6⑧ キシロカイン算定の標準化:** 医師・医事課・看護師の3者で算定基準を共有（1回の合同カンファで完了）

2026年改定シナリオ分析

楽観シナリオ（現行基準19%が継続）: 最優先戦略: C項目・A項目の算定精度最大化による安全バッファの積み上げ。Phase 1（4〜5月）の研修・テンプレート整備を予定通り完了し、目標を「常時22%超」に設定。

中立シナリオ（基準5%引き上げ → 基準24%）: 最優先戦略: C項目の件数拡大と救急搬送の積極受入による分子の最大化。

追加対策	追加効果	実現可能性
救急搬送受入を年220件→300件に拡大	+0.4%	中
C21の月8件→月12件へ拡大	+1.3%	中
C23（PEG・CART）の月2件→月4件へ	+0.8%	高
介護施設協定による安定入院ルート確保	分母の質向上	高

悲観シナリオ（基準10%引き上げ → 基準29% + 在院日数短縮圧力）: 最優先戦略: 患者ミックスの根本的転換 — 「重症・短期・高スコア」患者の戦略的受入。 - 地域包括医療病棟の「急性期受け皿機能」を前面に出す - キシロカイン点滴（A6⑧=3点）は他病院では算定しにくい独自武器 - 最悪シナリオ（基準29%）では「地域包括ケア病棟への全面転換」を先行検討

トレードオフ分析：在院日数17日→15日に短縮した場合

稼働率への影響

```
在院日数17日: 稼働率 = (150件×17日)÷(94床×30日) = 90.4%  ← 目標達成
在院日数15日: 稼働率 = (150件×15日)÷(94床×30日) = 79.8%  ← 目標を−10.2%下回る
稼働率回復には月間入院数を167件まで増加する必要あり
```

看護必要度への影響: 非該当期間（Day8〜17）が削減されるため、指数はわずかにプラス（+1〜2%程度）。ただし稼働率の悪化を補うほどではない。

収益への影響

```
在院日数17日（月150件）: ≈ 8,586万円/月（入院料部分）
在院日数15日（月150件）: ≈ 7,575万円/月
減収額: ≈ 1,011万円/月 = 約1.2億円/年
```

結論: 在院日数17日が稼働率と必要度の両立ゾーン。15日への短縮は件数補填なしには収益減。17日が現状の最適解。

5F vs 6F 優先順位

判断基準	5F（外科・整形、あと1.8%）	6F（内科・ペイン、あと6.8%）
費用対効果	高（少ない介入で達成）	中（多くの介入が必要）
リスク	低（達成確実性が高い）	高（未達成リスクあり）
時間軸	短期（2〜3ヶ月）	長期（6ヶ月）
放置した場合のリスク	低	**最高（入院料ダウンに直結）**

結論: 6Fを最優先としてリソースを集中投下。5Fは低コスト施策で並行処理。

推奨する実行スケジュール

```
Month 1–2（4～5月）:
  6F: キシロカイン算定フロー確立（医師+医事課+看護師の3者合意）
  6F: 電子カルテC項目チェックテンプレート導入
  5F: CV挿入C21算定の記録チェックリスト導入（低コスト施策）

Month 3–4（6～7月）:
  6F: 週次モニタリング開始·算定漏れ分析
```

```
  6F: PEG/CART適応患者の早期介入促進
  5F: 術後A項目記録の看護師向け研修（1回）→ 達成確認

Month 5–6（8～9月）:
  6F: 中間評価（18%超達成していれば微調整、未達なら追加施策）
 両F: 達成確認 → 月次レビュー体制に移行
```

経営領域 統合サマリー

タスク	最重要知見
問いのフレーミング	制約条件を先に固定することで、実行可能な問いになる
6F構造分析	A6⑧キシロカイン（単独3点）とC21内科系処置（4日間）が最大のレバー。記録改善が最速
シナリオ分析	楽観は「記録精度」、中立は「救急・C項目拡大」、悲観は「患者ミックス転換」
トレードオフ	在院日数17日が稼働率と必要度の両立ゾーン
優先順位	6Fを主戦場に集中。5Fは低コスト施策で並行処理

一言で表すなら: 6Fの問題は「やっていないことの問題」ではなく「やっていることを記録・算定していないことの問題」である。

総括：AI時代の問いの立て方 — 実践から得られた原則

三領域を貫く共通原則

原則	臨床	教育	経営
制約条件を先に明示する	PICO形式+PMID必須+反証要求	対象者・時間・行動変容目標	人員増加なし・6ヶ月以内・患者安全
定量化を要求する	LR+/LR-・感度・特異度	ルーブリック3段階・達成件数	ギャップ%・収益試算・在院日数
反証・限界を問う	「この診断を支持しない所見は？」	「認知バイアスの罠は何か？」	「このシナリオの最大リスクは？」

原則	臨床	教育	経営
アウトプット形式を指定する	表形式・PMID付き・意思決定フロー	ルーブリック・ケースシナリオ	シナリオ別・月次スケジュール

問いの質を上げる4ステップ

Step 1: 目的を先に言う
「～のために、～の観点から、～の形式で」

Step 2: 制約条件を明示する
「人員増加なし」「2020年以降の文献のみ」「5分で説明できる」

Step 3: 反証·盲点を要求する
「この回答の限界と、私が見落としている視点は？」

Step 4: 問いをAIに改善させる
「私の問いは適切か？より良い問いの立て方があれば提案して」

AI活用の役割分担

判断の種類	AIの役割	人間の役割
検索型（薬剤用量・文献）	主役	検証・確認
統合型（鑑別・戦略立案）	叩き台の提供	優先順位決定
判断型（治療・経営判断）	材料提供	最終決断
文脈型（患者の個別性・組織文化）	参考程度	主役

作成*:* おもろまちメディカルセンター 副院長・内科/呼吸器内科 検索エンジン*: PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)* 作成日*: 2026-03-20* 臨床情報*:* 患者個人情報を一切含まない架空シナリオおよび一般的文献情報